Processo nº 0027412-63.2023.8.17.2001

AUTOR(A): EDSON MARCIUS MOURA COIMBRA

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos etc...,

EDSON MARCIUS MOURA COIMBRA, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por meio de advogado legalmente habilitado, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL** em face da **CASSI – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, igualmente identificada.

Inicialmente, o autor requer os benefícios da gratuidade da justiça previstos nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Narra o demandante, em breve resumo, que é beneficiário do plano de saúde operado pela empresa Ré desde 21/09/1987 (Carteira nº 0300027090010004), estando adimplente com as mensalidades devidas e sem carências a cumprir.

Informa ser portador de depressão ansiosa grave, resistente ao tratamento, com ideação suicida (CID_{10} – F33.2), necessitando, com urgência, realizar tratamento com uso do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina intranasal), conforme laudo médico de Id. 128293038.

Aduz que, apesar de estar cumprindo com a sua parte na avença, a suplicada recusa-se a autorizar o custeio do seu tratamento, sendo, tal atitude da ré, abusiva e atentatória contra as normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e contra os seus direitos de consumidor.

Ante o relatado, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência antecipada, com o fito de determinar à demandada que autorize e custeie a realização do tratamento com a referida medicação, além de uma indenização pelos danos morais suportados.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Custas dispensadas em razão da gratuidade deferida.

Por meio da decisão de Id nº 128301118, foi indeferida a tutela de urgência requerida.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, a conexão com o processo nº 0027397-94.2023.8.17.2001 e, no mérito, alega que o feito não deve ser acolhido por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

Instada, a parte autora apresentou a devida réplica.

O feito seguiu seu trâmite regular.

Os autos volveram-me conclusos para julgamento.

RELATADO. DECIDO.

Inicialmente é de se frisar que, na hipótese, a produção de outros meios de prova se afigura desnecessária, isto porque os fatos narrados e os documentos colacionados pelas partes emergem suficientes para ensejar o pleno exame das questões postas, circunstância que, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Estatuto de Ritos, autoriza o julgamento antecipado da lide.

Feitas tais considerações, passo a analisar a tese de conexão suscitada:

Aqui, a despeito dos argumentos apresentados, tenho que a tese de conexão não deve ser acatada.

É que apesar das partes serem as mesmas, os pedidos não se confundem, pois se neste processo se debate a negativa de fornecimento de um medicamento que seria, em tese, de uso domiciliar, naquele feito se debate a cobertura de um tratamento propriamente dito, qual seja a EMT (Estimulação Magnética Transcraniana".

Assim, deixo de acolher a tese de conexão por absoluta falta de amparo legal.

Feitas tais considerações, passo ao mérito propriamente dito:

Inicialmente, passo a analisar a questão da aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 (CDC, Código de Defesa do Consumidor) ao presente caso.

Sem maiores digressões, tenho que após a edição da Súmula 608, do STJ, as discursões acerca da aplicabilidade do CDC aos contratos de autogestão perdeu razão de ser. É que a referida súmula é clara ao excluir do âmbito de incidência do CDC os planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como abaixo está evidenciado:

> Súmula 608-STJ: **"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".**

Assim, resta afastada a incidência do CDC ao presente caso.

No mérito, o autor intenciona o deferimento do tratamento sonegado, como meio necessário ao bom êxito de sua recuperação, bem como o ressarcimento pelos danos morais suportados, em virtude da negativa de cobertura do tratamento prescrito.

Diante dos fatos narrados, assim como das provas produzidas, tenho que razão assiste ao requerente no que se refere aos seus pedidos. Vejamos.

É incontroverso que o demandante apresenta a enfermidade descrita no exordial, necessitando, por consequência, do tratamento requerido, com vistas a maximizar as possibilidades de êxito, tudo em absoluta consonância com o laudo médico apresentado.

Por seu turno, a ré afirma, em sua contestação, que a negativa é devida por tratar-se de medicamento de uso domiciliar.

No caso em apreço, sobressai evidente que, em se tratando de tratamento estritamente necessário e indispensável à manutenção da boa qualidade de vida do autor, a recusa da ré, alegando exclusão de cobertura do contrato, revela-se contrária à natureza do contrato de assistência médico-hospitalar, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual.

A questão relacionada ao uso domiciliar do medicamento prescrito, no caso em análise, deve ser relativizada. É que, após a devida triangularização processual, restou evidenciado que, embora de uso domiciliar, a presente medicamente deve ser ministrado com a supervisão médica.

Acrescente-se, ainda, que a alegação de uso domiciliar não pode servir de único lastro para o seu não fornecimento, sob pena da saúde do autor restar prejudicada, desvirtuando assim por completo o espirito do contrato de proteção a saúde firmado com a empresa ré.

O TJPE vem trilhando entendimento semelhante, senão vejamos:

> **DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SASSEPE. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. CONVENIADA PORTADORA DE DEPRESSÃO RECORRENTE GRAVE, COM IDEAÇÃO SUICIDA. NECESSIDADE DE USO DO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.** 1.Consoante teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.Neste caso, a autora ajuizou ação ordinária, pugnando a determinação para que o IRH custeie o tratamento da patologia que a acomete, qual seja, depressão grave, com o medicamento SPRAVATO SPRAY NASAL, conforme laudo médico acostado aos autos. 3.A demandante é beneficiária do SASSEPE e se encontra acometida de Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID 10 33.2), conforme laudo médico, no qual o médico Psiquiatra, Dr. Carlos Gustavo Arribas, CRM 15784, atesta que a paciente já fez uso de vários tratamentos sem resposta terapêutica, além de possuir ideação suicida, humor depressivo e incapacidade cognitiva, com péssimo prognóstico, necessitando do uso do medicamento SPRAVATO SPRAY NASAL durante 12 semanas ininterruptas em

ambiente hospitalar, além de terapia ocupacional e teste neuropsicológico. 4.O medicamento em questão, SPRAVATO® (cloridrato de escetamina), é indicado, em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda, e tem registro na Anvisa sob o número 1123634350030. 5.Ressalta-se, inicialmente, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SASSEPE, plano de autogestão, conforme teor da Súmula nº. 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 6.Saliente-se, como bem enfatizado pelo Ministério Público, que: "embora afastada a incidência do CDC, as relações existentes entre o SASSEPE e seus beneficiários permanecem disciplinadas pelo Código Civil, em especial as regras que impõem o dever de boa-fé objetiva e estabelecem interpretação favorável ao aderente em contrato de adesão, observando-se, evidentemente, a peculiaridade de ser um plano de saúde mantido por uma autarquia estadual". 7.A prova documental trazida aos autos não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao estado de saúde da autora/agravante e à necessidade do tratamento indicado pelo médico assistente. 8.O direito à vida, bem fundamental e inviolável, se sobrepõe ao rigor formal, sendo garantido constitucionalmente, tudo conforme os artigos 6º e 196, da Carta Magna. 9.O SASSEPE é regulado pela Lei Complementar Estadual nº 30/2001. Importante destacar que, mesmo havendo previsão de que a assistência à saúde será prestada com a amplitude permitida pelos recursos financeiros auferidos pelo IRH-PE, bem como que a cobertura admitida para os programas de assistência à saúde será aquela constante do rol de procedimentos definidos em resolução do CONDASPE, entende-se que o SASSEPE está, sim, obrigado à prestação de saúde aos seus beneficiários, devendo-lhes prestar assistência. 10.Assim, não se poderia permitir que uma pessoa portadora de grave enfermidade não recebesse o tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático. Quando há confronto entre os interesses econômicos do recorrido e o direito à saúde e à vida do recorrente, devem estes se sobrepor àqueles. 11.Vale salientar que cabe somente ao médico identificar a doença e encontrar o melhor meio para um tratamento eficaz, sendo certo que, conforme atestado pelo psiquiatra que acompanha a autora, várias outras tentativas terapêuticas foram efetuadas sem sucesso. 12.Insta ressaltar que, embora a situação jurídica em questão seja diversa daquela imposta diretamente ao Estado, já que o pleito da autora decorre de relação jurídica mantida com o SASSEPE, cumpre ao Ente Público, através do referido plano dos seus servidores, fornecer o medicamento/tratamento pleiteado, sobretudo quando se sabe que mesmo quando não há contraprestação, o Estado deve fornecer o tratamento, que dirá no caso em liça, em que a beneficiária

contribui mensalmente para a manutenção do Sistema de Saúde do qual, nesse momento, necessita urgentemente. 13.Assim, verificada a veracidade dos fatos e a urgente necessidade do tratamento da paciente, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. 14.Ressalte-se, por fim, que esta Corte de Justiça tem posicionamento favorável à concessão do medicamento em tela, nas ações intentadas em face de planos de saúde. Precedentes: TJ-PE - AI: 00071845620228179000, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)); TJ-PE - AI: 00121280420228179000, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 09/09/2022, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins. 15.Atento ao que dispõe o art. 537 do CPC, é razoável a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação e a fixação de multa diária, em R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial. 16. Agravo de Instrumento provido. Reforma da decisão agravada, no sentido de deferir a tutela de urgência postulada na inicial, determinando que o SASSEPE custeie o tratamento da autora, conforme solicitação médica acostada aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e a determinação de bloqueio judicial do valor necessário para a realização do tratamento. 17. Agravo Interno prejudicado. 18. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0020996-68.2022.8.17.9000, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 7 (TJ-PE - AI: 00209966820228179000, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 16/03/2023, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXISTÊNCIA DE DOENÇA IMPLICA EM COBERTURA DO TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. OCORRENDO O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL CABÍVEL A MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.O agravado, diagnosticado com depressão grave refratária e ideação suicida, tem

prescrição médica para uso do medicamento SPRAVATO, necessário à sua intervenção emergencial. 2.A operadora do plano de saúde, nega cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual, configurando abusividade segundo o art. 51, IV, do CDC, por colocar o segurado em risco grave à sua integridade e vida. 3. É irrelevante o local onde será ministrado o medicamento para fins de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde. Precedentes do STJ. 4. A operadora de saúde descumpriu a ordem judicial, tendo o autor requerido a majoração das astreintes, bem como o bloqueio da quantia necessária à realização do tratamento com o medicamento, devendo a quantia ser mantida, sob pena de contumaz descumprimento pela parte agravante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0008959-72.2023.8.17.9000, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife, data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 01(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0008959-72.2023.8.17.9000, Relator: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. MEDICAMENTO SPRAVATO (ESCETAMINA). DEPRESSÃO RESISTENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de custeio do medicamento

SPRAVATO (escetamina) por plano de saúde, sob a justificativa de cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento psiquiátrico. 2. A cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento psiquiátrico é considerada abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 3. A Resolução Normativa nº 465/21 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura de todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas. 4. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998, permitindo a cobertura de tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, desde que prescritos pelo médico assistente e baseados em evidências científicas. 5. **Comprovada a necessidade do medicamento SPRAVATO (escetamina) para o tratamento de depressão resistente, conforme prescrição médica, e evidenciada a ineficácia dos tratamentos anteriores, configura-se a probabilidade do direito e o perigo de dano. 6. Reforma da decisão recorrida para deferir a tutela antecipada, determinando que a agravada BRADESCO SAÚDE S/A custeie o medicamento SPRAVATO (escetamina), conforme prescrição médica, sob pena de multa mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.** ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste recurso de Apelação Cível, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator. P. e I. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00210457520238179000, Relator: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 19/06/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEPRESSÃO GRAVE. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LEI Nº 9.656/98. CDC. CÓDIGO CIVIL. ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA ILÍCITA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de prescrição, em caráter de urgência/emergência, de medicamento (SPRAVATO) com depressão grave e risco de desfecho fatal, cujas tentativas anteriores de tratamento resultaram infrutíferas. 2 – Inexiste comprovação de uso off label do medicamento e, ainda que houvesse, não estaria afastado o dever contratual de custeio a fármaco registrado na Anvisa e prescrito como tratamento necessário para problema grave cujas terapias intentadas previamente restaram frustradas. 3 – O rol da ANS funciona como mera referência básica que não inclui todos os procedimentos a serem cobertos pelas seguradoras, ao que se soma o entendimento do STJ quanto à taxatividade mitigada, do que se extrai o dever de cobertura do plano de saúde quanto aos procedimentos que não encontram substitutos terapêuticos inseridos na lista, sendo este o caso dos autos. 4 – Aplicáveis ao caso o CDC e as normas civis em matéria contratual, sendo certo que a negativa de cobertura frustra a legítima expectativa da segurada de receber a assistência médica adequada em momento de necessidade, expondo-a a vulnerabilidade ainda maior, ampliando sua angústia e comprometendo o equilíbrio da relação contratual, além de ofender a dignidade da pessoa humana e o escopo maior do contrato, que é a proteção da saúde e da vida. 5 – Configurados a conduta ilícita e os danos morais (in re ipsa) a ensejar indenização. Valor mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atentar para as circunstâncias do caso e a posição das partes, bem assim para as finalidades reparadora e punitivo-pedagógica da medida, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do TJPE. 6 – Apelo NÃO PROVIDO. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0041807-60.2023.8.17.2001, os desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade da ata de julgamento e nos termos do voto do Relator, acordam à unanimidade em NEGAR PROVIMENTO à apelação, majorando-se a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Recife, data conforme a certificação digital. Desembargador Bartolomeu Bueno Relator)(TJ-PE - Apelação Cível: 00418076020238172001, Relator: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 27/08/2024, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais)

Os demais tribunais pátrios não discrepam desse posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR- INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. = TRATAMENTO DE CIRROSE HEPÁTICA. - CLÁUSULA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O plano de saúde deve fornecer todo o tratamento necessário ao paciente, incluindo aí o fornecimento de medicamento específico e imprescindível para o tratamento com previsão contratual de cobertura, seja este ministrado no âmbito hospitalar ou domiciliar, não cabendo ao Plano de Saúde controlar o uso, mas sim, em ambos os casos, arcar com os custos, a fim de garantir o menor sofrimento possível ao paciente e a consequente sobrevivência digna. 2. **Mesmo o contrato não prevendo o fornecimento de medicamento para uso domiciliar, bem como a Lei de Planos de Saúde e a Resolução Normativa da ANS admitam a exclusão de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, no caso específico dos autos, há de ser interpretado o instrumento contratual em prol do bem maior que é a saúde do consumidor, não sendo pertinente a aplicação dos aludidos dispositivos legais presentes.** 3.São abusivas as cláusulas contratuais que limitam a cobertura do atendimento médico. Precedentes do STJ. 4. O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0570978-68.2016.8.05.0001, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/02/2018 (TJ-BA – Apelação 05709786820168050001)

Aqui, para além dos argumentos acima mencionados, deve-se observar, especialmente, os princípios da dignidade da pessoa humana, não podendo a seguradora se recusar a autorizar os tratamentos necessitados pelo paciente, quando a sua ausência importar sequelas irreversíveis ao enfermo.

Assim, a meu ver, é ilegítima e abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento da forma como foi prescrito para o demandante, pois expressamente solicitado pelo médico que o acompanha, com o fito de maximizar a possibilidade de cura.

Assim, havendo cobertura da doença do autor, o plano não pode excluir o tipo de tratamento utilizado e mais adequado para a sua respectiva cura. Havendo previsão de exclusão do tratamento, cuja doença a que se relaciona encontra cobertura, a cláusula contratual correspondente é abusiva, não podendo vigorar.

Assim, uma vez reconhecida a abusividade da negativa do plano demandado, é de consequência inconteste o acolhimento do pedido exordial, pelo que fica reconhecida a ilicitude da recusa ofertada pelo plano de saúde réu.

Igualmente, merece chancela o pedido de condenação em indenização pelos danos morais suportados.

A questão relativa ao dano moral foi bem tratada por Rui Stocco em sua obra: Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial: Doutrina e Jurisprudência (São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995), na qual leciona que a Carta Magna deixou "palmar no art. 5º, inciso V e X, que a ofensa moral está intimamente ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e outras hipóteses" (p. 498).

De fato, o dano moral não reflete desfalque patrimonial, mas qualquer atentado à tranquilidade, às expectativas intimamente construídas em razão de contratos celebrados, materializando-se, in casu, na injusta recusa no cumprimento do contrato de assistência à saúde há muito celebrado.

Em sintonia com tal tese, o Tribunal de Justiça de Pernambuco pacificou entendimento de que: **a negativa de cobertura fundada em cláusula de contrato de assistência à saúde rende ensejo à indenização por dano moral**. (Súmula 35).

O dano não se avalia mediante cálculo matemático-econômico das repercussões patrimoniais negativas da violação (RDP 185/198), em nossos dias, tem ele uma dimensão e um espectro muito mais amplo e dilargado, no qual não mais subsiste a ultrapassada ideia central da dor como único fundamento. Nesta nova percepção, pouco importa qual a causa da lesão ou quem seja a vítima do gravame, se pessoa física ou jurídica. Importa saber, como assevera Rui Stocco, na obra acima referida (p. 499), "qual foi o resultado ou o efeito da ofensa. Se decorreu prejuízo material, palpável, efetivo, a lesão terá sido patrimonial. Se, ao contrário, experimentou-se prejuízo não-patrimonial, mas, de qualquer modo, uma ofensa ou lesão verificável, terá ocorrido a ofensa moral".

A vexatória e indevida negativa de autorização do medicamento, sem causa legal ou fática que a legitime, constitui abuso de direito que se enquadra no enunciado do artigo 186, do Código Civil e por isso é ato ilícito, provocador de reparação pecuniária através dos critérios compensatórios e sancionatórios, visando a

recomposição do patrimônio moral aviltado, com base nos efeitos do ato lesivo, de modo a proporcionar ao ofendido compensações outras, capazes de retribuir-lhe satisfações e alegrias na justa medida do abalo sofrido.

A jurisprudência dominante tem reconhecido lesividade em situações da tonalidade ora demonstrada:

> PLANO DE SAÚDE – SEGURADO – CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – DESCONSIDERAÇÃO – Os contratos celebrados para assistência à saúde, se identificam como de prestação de serviço e devem obediência às regras do Código de Defesa do Consumidor no que respeita às cláusulas ditas abusivas, como o são aquelas que colocam o usuário do serviço em desvantagem exagerada em relação àquele que os presta; a inadimplência de sessenta dias que autoriza a suspensão do contrato é aquela é a contínua e não a que soma pequenos dias de atrasos alternados ocorridos ao longo do pacto. Constatado que o segurado estava com suas prestações atualizadas, a recusa em atendê-lo quando necessitou do serviço, é certa que lhe acarretou prejuízos de natureza moral e material, esta, quando ele teve que desembolsar recursos próprios para tratar-se de sua enfermidade; o dano material é o que ficou, objetivamente, provado, enquanto que o dano moral, que tem natureza subjetiva, deve ser arbitrado, segundo as circunstâncias do caso, suas conseqüências, partes envolvidas, tendo sempre presente que a condenação, que reverterá em favor do ofendido, tem caráter educativo, e, por isso, há que ser arbitrada de modo a não se revelar insignificante, e, por outro lado, não deve ser tão elevada para não se converter em locupletamento (TJMA – AC 019119/2002 – (44.287/2003) – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Stélio Muniz – J. 24.04.2003).

Deste modo, no caso em tela, a condenação da ré a reparar os prejuízos de ordem moral suportados pelo segurado, se impõe e tem caráter compensatório. Contudo, as nossas Cortes são uníssonas quanto à necessidade de prudência quando da fixação do montante:

> Trata-se, então, de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo Juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre por em ação calculadora do economista ou de técnicos em contas (RT 650/66).

> DANO MORAL. REPARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA - No arbitramento do valor do dano moral é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. A intensidade da culpa, a violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade (TJRJ - 8ª C. - Ap. - Rel. Silveira Neto - j. 29.10.92 - JTJ- LEX 142/104).

A vítima de lesão de direitos de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva (TJSP - 7º Rel. Campos Mello j. 30.10.91 RJTJESP 137/187).

Nesse panorama, a compensação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aquilatados de acordo com as peculiaridades que envolvem o pleito (STJ - RESP 200500465226 - (736968) - RJ - 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini - DJU 01.07.2005 - p. 00559).

Considerando todos esses pressupostos, bem como, ainda, as circunstâncias advindas do caso concreto, fixo a quantia indenitária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi o montante requerido pela parte autora.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, resolvo julgar **PROCEDENTES** os pedidos formulados pelo demandante, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para, em consequência, adotar-se as seguintes providências:

a) determinar a ré que autorize e custeie, integralmente, o tratamento do autor com a medicação SPRAVATO, nos exatos termos do laudo médico apresentado nos presentes autos;

b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela tabela do ENCOGE e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da presente decisão;

c) Por fim, condenar a ré ao pagamento das custas processuais, assim como de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e, verificada a inércia das partes, arquivem-se os autos, com a respectiva baixa na distribuição.

P. R. I.

Recife, 09 de agosto de 2024

Sylvio Paz Galdino de Lima

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: SYLVIO PAZ GALDINO DE LIMA
11/09/2024 16:13:00
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 181893049

24091116130029100000177456096